EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 86482
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-12 09:58:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOVITA DEL CARMEN SEPULVEDA SEPULVEDA			RUN	: 6.799.138-9
F.Nac	: 29-06-1947	Edad	: 76 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LAS ROSAS CHACAY			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 097152387		
Fecha Ingreso	: 29-05-2024	Fecha Egreso	: 2024-06-12 09:58:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Infarto ACM izquierda 2° a oclusión ACI supraclinoidea + M1 proximal (fronto-operculo-insular, temporal anterior, putamen, nucleo caudado), TH PH-1
-Dependencia severa, mRS 5
-FA sin TACO (rivaroxaban, previamente con buena adherencia)
-GTT por disfagia neurogénica severa
-Trombo AI (orejuela tipo "chicken wing")
-Neumonía aspirativa tratada
-Déficit B12 suplementado
-Ant: HTA - ICC - Hipotiroidismo - Hipoacusia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

REG, HDN estable, FA sin RVR, eupneica, afebril, impresiona sin dolor, confusa, estacionaria en lo neurológico.
Se instaló GTT ayer sin incidentes, inició alimentación por esta vía con buena tolerancia.
TC cerebro muestra TH PH-1 en putamen y cabeza n. caudado izquierdos con efecto de masa moderado sobre VL ipsilateral, IH-1 temporal izquierdo (en TC de cerebro del 30/4 no se observaban lesiones hemorrágicas).
AngioTC cerebro y cuello muestr aoclusión de ACI supraclinoidea hasta M1 ipsilateral, infartos agudos fronto-insular, corona radiada y putamen izquierdo; AI muy dilatada, trombo en orejuela izquierda (tipo "chicken wing").
Actualmente con contraindicación absoluta para uso de antitrombóticos, se pospone reinicio de DOAC, suspendo AAS.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio, IC HODOM para rehabilitación (KNTM y Fonoaudiología) y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-IC HODOM para rehabilitación (KNTM y Fonoaudiología)
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Atorvastatina 40 mg/noche
2. -Digoxina 0.25 mg/día de Lunes a Viernes

3. -Bisoprolol 2.5 mg 2 comp c/12 horas
4. -Levotiroxina 100 ug 1/2 comp al día
5. -Furosemida 40 mg 1/2 comp c/12 horas
6. -Espironolactona 25 mg/día
7. -Amiodarona 200 mg/día
8. -Losartan 50 mg/día

EXÁMENES Y RESULTADOS

10/6/24
-Glic 110
-Crea 0.5 MDRD 119.67
-Ca 8.7 Na 141 K 3.5 Cl 107
-PCR 17.7
-Hb 13.8 Leu 13600 Plaq 185000 Seg 86
-INR 1.29

8/6/24
-Crea 0.5 MDRD 119.96 Uremia 23
-Ca 9 Na 140 K 3.6 Cl 106

7/6/24
-Ca 8.4 Mg 2.1 Na 136 K 3.4 Cl 106

6/6/24
-Crea 0.5 MDRD 119.96 Uremia 21
-Ca 8.3
-PCR 25.3
-Na 138 K 3.2 Cl 106
-Procal 0.06
-Leu 10400 Hb 12.8 Plaq 160000 Seg 78 VHS 8

4/6/24
-Alb 3.6
-Crea 0.5 MDRD 119.96 Uremia 20
-AU 2.7
-Ca 8.3 P 2.7 Mg 2.2 Na 142 K 3.8 Cl 110
-FA 104 BI 1.59 BD 0.21 BT 1.8 GOT 50 GPT 38 GGT 39
-PCR 40.6
-Leu 12300 Hb 13.3 Plaq 157000 Seg 80 VHS 16
-Procal 0.06

2/6/24
-Glic 120
-Alb 3.6
-Crea 0.5 MDRD 119.96 Uremia 25
-Lact 1
-PCR 31.5
-Na 143 K 3.3 Cl 112
-Leu 12200 Hb 13.3 Plaq 151000 Seg 84 VHS 11
-INR 1.21 TTPA 29
-Procal 0.05

30/5/24
-Alb 4.1
-Crea 0.7 MDRD 81.36 Uremia 32
-AU 4.1
-PCR 6.7
-Na 142 K 3.6 Cl 111
-Leu 12500 Hb 13.2 Plaq 169000 Seg 84 VHS 8
-TSH 1.314 T4L 0.79

-B12 136 Folato 21.7
-OC N
-RPR N/R

29/6/24
-Crea 0.6 MDRD 97.2 Uremia 34
-Amilasa 73 Lipasa 96
-Ca 8.9
-FA 73 BI 0.97 BD 0.33 BT 1.3 GOT 35 GPT 25 GGT 24
-CKMB 23 CK 168
-Lact 2.1
-PCR <5
-Na 142 K 4.1 Cl 113
-Hb 13.5 Leu 7600 Plaq 155000 Seg 75
-INR 1.25 TTPA 28
-Trop 6.9

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RII 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+), SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BD, RHA(+), no palpo visceromegalia, dolor al palpar hemiabdomen inferior, Blumberg(-), globo vesical(+)
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, emite sonidos ininteligibles, no nomina ni repite, localiza al dolor, con actividad motora voluntaria (taparse con frazada)
-PC: impresiona hemianopsia derecha por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC der moderada, disartria severa, sensibilidad facial algésica conservada con maniobra de Foix, nistagmo(-), úvula y lengua centrales, ausencia de reflejo nauseoso, resto n/e
-Motor: ESD M2, EID M2-3, ESI M5, EII M3-M4(-), RCP extensor derecho
-Sensibilidad: algesia impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO